

MediScribe 门诊接诊至病历生成全流程说明

AI 临床接诊智能助手 · 门诊场景 workflow（含界面实拍）

MediScribe (mediscribe.cn) | 2026 年 7 月 | 供 HIS 厂商对接参考 | 文中截图均取自系统测试环境，患者数据为演示虚构

本文档完整展示 MediScribe 在**门诊场景**下，从医生接诊开始、到 AI 生成病历、再到医生审核签发归档的全过程。每个环节附系统界面截图与详细文字说明。急诊、住院流程结构相同（以病历类型区分），本文暂不展开；影像等模块与本次对接无关，亦不涉及。

一、流程总览



■ 黄色环节为与 HIS 的两个衔接点：①「接诊建档」由 HIS 接诊推送触发替代（推送就诊流水号 + 患者基本信息，患者自动派入医生工作台并叫号提醒）；⑧「签发归档」后沿同一连接下发病历回写（写入 + 刷新，以就诊流水号对应到当次就诊）。中间 ②-⑦ 全部在 MediScribe 内完成，不依赖 HIS 推送任何病历内容。

二、分步骤详解

1 医生登录

医生使用账号密码登录系统，登录时选择「门诊系统」（另有住院系统入口，本文不涉及）。登录后系统即绑定当前医生身份（科室、姓名），后续所有病历操作均落到该医生名下。

与 HIS 对接后：接诊推送消息中携带医生工号，我方按工号自动把患者派入该医生已登录的浏览器工作台并叫号提醒，医生无需重复录入患者信息。

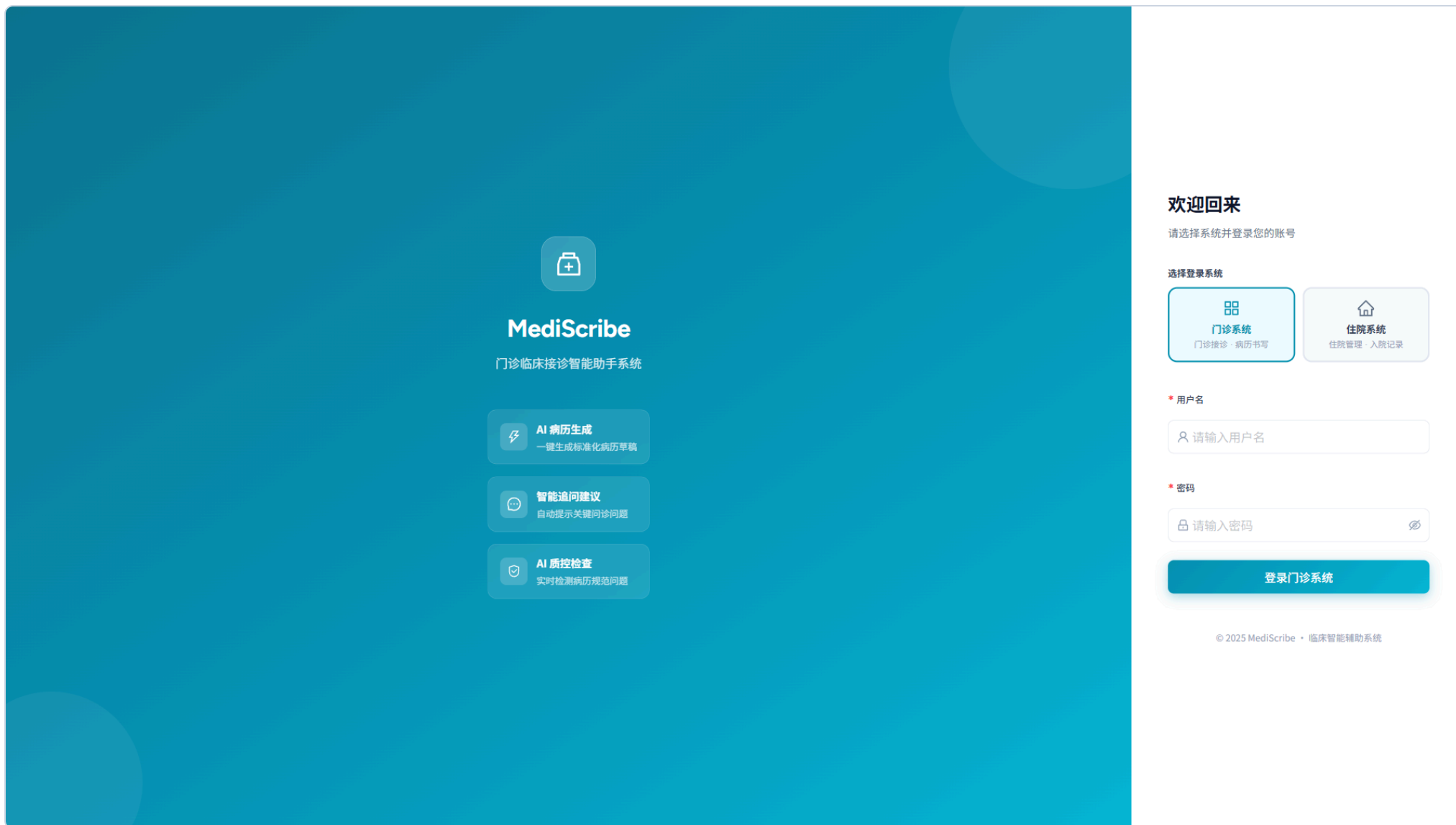


图 1 登录页：选择门诊系统，输入账号密码

2 接诊工作台总览

登录后进入接诊工作台，三栏布局对应病历产生的三个阶段：

- **左栏·问诊录入**：语音录入区、就诊/病发时间、主诉、现病史、体格检查（生命体征 + 中医四诊）、诊断、治疗意见等结构化字段；

- **中栏·病历草稿**：病历正文编辑区，工具栏含「一键生成、润色、AI 质控、出具最终病历、导出 Word」；
- **右栏·智能辅助**：追问建议、检查建议、质控提示三个标签页。

顶栏提供「初诊 / 复诊」入口与当前患者信息；底部状态栏实时显示接诊状态与病历保存时间。

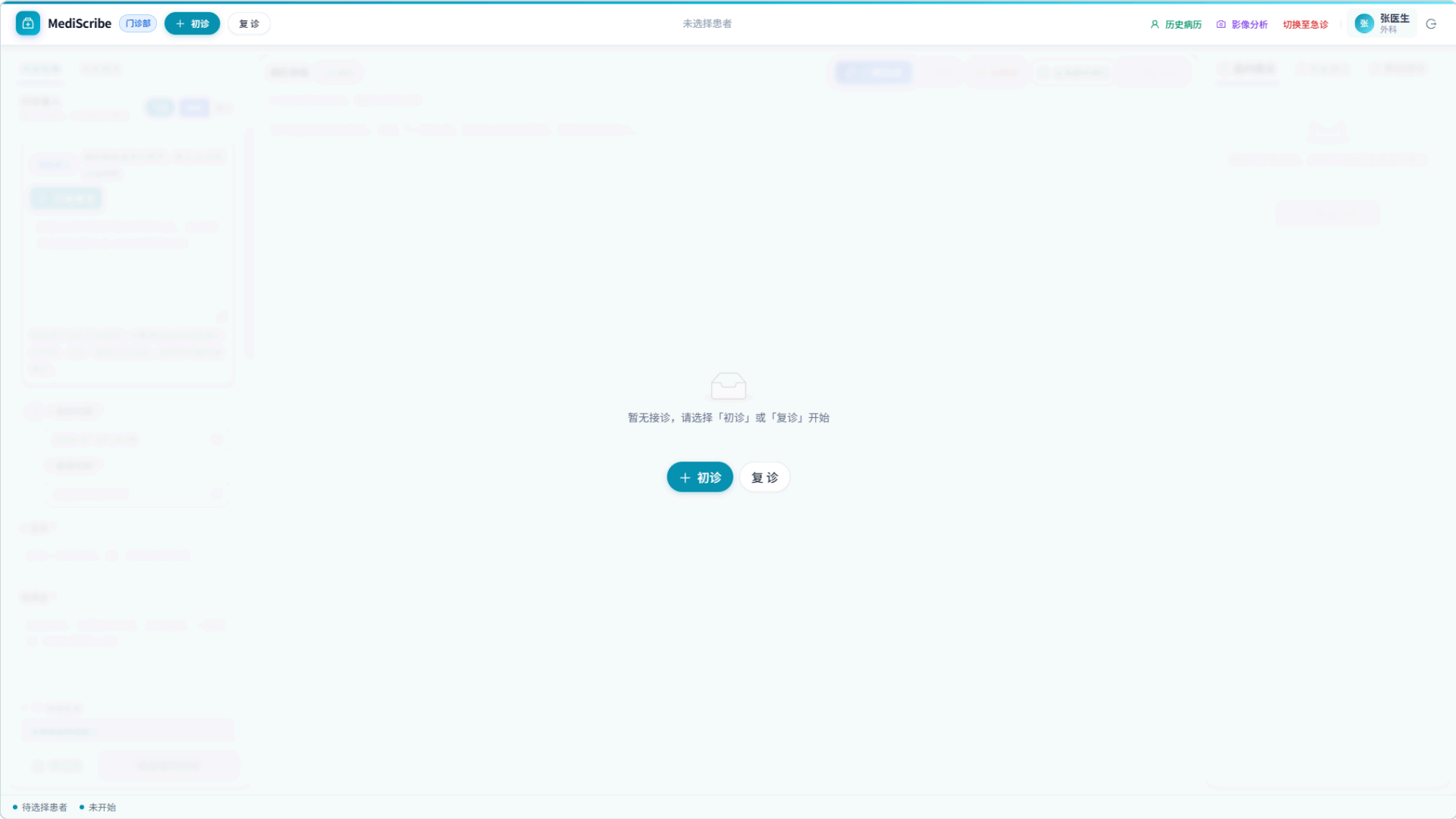


图 2 接诊工作台（未接诊状态）：左问诊、中病历、右辅助

3 接诊建档（初诊登记）

HIS 衔接点 ①

医生点击「初诊」，填写患者基本信息：姓名、性别、出生日期为必填，身份证号、民族、职业、联系电话、住址等为选填（身份证号用于复诊与转住院时的患者去重）。点击「开始接诊」后系统建立本次就诊，生成就诊号，顶栏显示当前患者（姓名 / 性别 / 年龄 / 就诊号）。复诊患者则直接从档案中选择，历史信息自动带出。

与 HIS 对接后：这一步整体由 HIS 接诊推送替代——医生在 HIS 点「接诊」，HIS 将就诊流水号、患者姓名/性别/出生日期、科室、医生等基本信息推送给我方，我方自动建档并派入该医生工作台、叫号提醒，医生点击即进入，无需手工录入。就诊流水号将贯穿本次就诊，签发后回写时原样带回。

MediScribe

门诊部

初诊

复诊

未选择患者

历史病历

影像分析

切换至急诊

张医生
外科

初诊登记

* 患者姓名

陈桂芳

* 性别

女

* 出生日期

1968-05-20

身份证号

选填，建议录入以便复诊/转住院去重

民族

请选择民族（选填）

婚姻状况

请选择（选填）

职业

退休

联系电话

13900005678

工作单位

选填（无业/退休可填无）

住址

选填

就诊类型

门诊

取消

开始接诊

图 3 初诊登记弹窗（对接后由 HIS 推送自动完成）

4 语音问诊采集

接诊开始后，医生点击「开始录音」，即可与患者自然对话问诊，系统实时把语音转写为文字显示在转写区；也支持直接粘贴第三方语音转写文本。**原始录音与转写全文都会在后台留档保存**，作为病历内容的溯源依据。问诊过程中医生无需打字、不打断诊疗节奏。

MediScribe

门诊部

初诊

复诊

取消接诊

陈桂芳 女 58岁 #BC6541

历史病历

影像分析

切换至急诊

张医生 外科

问诊信息

检验报告

问诊录入

填写后保存, AI自动同步建议

门诊

初诊

复诊

同步上次病历

既往病史、手术史、传染病史; 无特殊可填「既往体质可」

过敏史

如: 青霉素过敏 / 否认药物及食物过敏史

个人史

吸烟、饮酒、职业、生活习惯; 无特殊可填「无特殊」

家族史

直系亲属重要疾病史; 无特殊可填「无特殊」

长期用药

正在服用的药物名称、剂量、用法; 无可填「无」

婚育史

婚姻、生育情况; 无特殊可填「适龄结婚, 配偶子女体健」

宗教信仰

如: 无 / 佛教 / 基督教 (涉及禁忌时填...

语音录入

保存原始录音与转写, 并让 AI 识别对话结构

继续录音

AI分析并整理

清空重录

——舌红, 苔黄。再把个脉——脉弦有力。
医生: 您这个情况考虑是血压没控制好引起的头晕, 先做个头颅CT排除一

转住院

尚未填写问诊

病历草稿

门诊病历

一键生成

润色

AI质控

出具最终病历

导出 Word

AI生成内容仅供参考, 请医生审核后使用

填写左侧问诊信息后, 点击「一键生成」自动生成病历草稿, 或直接在此输入...

追问建议

检查建议

质控提示

保存问诊信息后, 点击下方按钮生成追问建议

生成追问建议

陈桂芳 · 接诊中 · 未开始

图 4 语音转写区: 医患对话全文实时呈现 (本例为高血压患者头晕就诊)

5 AI 分析整理, 自动回填问诊字段

问诊结束后点击「AI 分析并整理」, AI 对对话完成三件事:

- **生成对话摘要:** 一段话概括本次问诊要点;

- **医患角色区分**：把对话逐句拆分标注「医生 / 患者」，不确定的内容单独标记；
- **结构化回填**：从对话中抽取信息，自动填入主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、长期用药、血压等生命体征、舌象脉象、初步诊断、治疗意见等全部对应字段。

数值真实性原则：血压、体温等**测量数值**只从医生在对话中口述的**实测值提取，AI 绝不编造**；对话中没有提到的字段保持空白，由医生补填或走后述质控补全流程（补全内容需医生确认）。

MediScribe

门诊部

初诊

复诊

取消接诊

陈桂芳 女 58岁 #BC6541

历史病历 影像分析 切换至急诊 张医生 外科

问诊信息 检验报告

问诊录入

填写后保存, AI自动同步建议

门诊 初诊 复诊

同步上次病历

高血压病史7-8年

过敏史

如: 青霉素过敏 / 否认药物及食物过敏史

个人史

否认吸烟、饮酒史

家族史

父亲有高血压病史, 因脑梗去世

长期用药

苯磺酸氨氯地平 1片/日, 近期服药不规律

婚育史

婚姻、生育情况; 无特殊可填「适龄结婚, 配偶子女体健」

宗教信仰

如: 无 / 佛教 / 基督教 (涉及禁忌时填...

档案有未保存的修改 — 点击下方“保存”按钮— 并提交

语音录入

保存原始录音与转写, 并让 AI 识别对话结构

继续录音 重新分析

清空重录

——舌红, 苔黄。再把个脉——脉弦有力。

转住院 保存档案+问诊

病历草稿 门诊病历

一键生成 润色 AI质检 出具最终病历 导出 Word

AI生成内容仅供参考, 请医生审核后使用

填写左侧问诊信息后, 点击「一键生成」自动生成病历草稿, 或直接在此输入...

追问建议 检查建议 质控提示

保存问诊信息后, 点击下方按钮生成追问建议

生成追问建议

陈桂芳 • 接诊中 • 未开始

图 5 AI 整理完成：主诉「头晕3天」、现病史、血压 162/96、舌象脉象、诊断等字段已自动回填

6 保存问诊，病历草稿自动生成

医生核对回填内容后点击「保存档案+问诊」，系统随即按**门诊病历模板**把问诊信息汇编为结构化病历草稿，显示在中栏编辑区，章节包括：就诊/病发时间、主诉、现病史、既往史、过敏史、个人史、体格检查（生命体征 + 中医望闻切诊）、辅助检查、诊断（中医病名/证候 + 西医诊断）、治疗意见及措施（治则治法、处理意

见、复诊建议、注意事项)。缺失章节以「[未填写，需补充]」显式占位，防止遗漏。草稿全程自动保存，医生可在编辑区直接修改任意内容。同时，既往史、过敏史、家族史等「患者档案」类信息会跟随患者长期留档，复诊时自动带出，只需确认更新。

MediScribe

门诊部

+ 初诊

复诊

取消接诊

陈桂芳 女 58岁 #BC6541

历史病历

影像分析

切换至急诊

张医生 外科

问诊信息

检验报告

问诊录入

填写后保存，AI自动同步建议

门诊

复诊

——舌红，苔黄。再把个脉——脉弦有力。

医生 您这个情况考虑是血压没控制好引起的头晕，先做个头颅CT排除一下脑血管问题，再查个血脂血糖。药不能再忘吃了。

语音原文会在后台保存；AI整理后展示预览，确认无误后点击「插入病历」写入对应章节。

* 就诊时间 *

2026-07-14 14:10

* 病发时间 *

2026-07-11 08:00

* 主诉 *

头晕3天

现病史 *

患者3天前无明显诱因出现头晕，晨起时明显，呈天旋地转感，伴恶心，无呕吐，无耳鸣、听力下降，无视物重影。

√ 体格检查

生命体征快速录入

T 36.5 °C P 72 次/分 R 18 次/分

BP 162 / 96 mmHg SpO2 98 %

转住院

病历草稿已生成并自动保存。可继续录音补录，AI整理后点「插入病历」即可写入对应章节。

病历草稿

门诊病历

一键生成

润色

AI质控

出具最终病历

导出 Word

AI生成内容仅供参考，请医生审核后使用

就诊时间：2026-07-14 14:10 病发时间：2026-07-11 08:00

【主诉】

头晕3天

【现病史】

患者3天前无明显诱因出现头晕，晨起时明显，呈天旋地转感，伴恶心，无呕吐，无耳鸣、听力下降，无视物重影。

【既往史】

高血压病史7-8年

【过敏史】

[未填写，需补充]

【个人史】

否认吸烟、饮酒史

【体格检查】

BP:162/96mmHg

望诊：[未填写，需补充]

闻诊：[未填写，需补充]

切诊·舌象：舌红，苔黄

切诊·脉象：脉弦有力

其余阳性体征：[未填写，需补充]

【辅助检查】

[未填写，需补充]

【诊断】

中医诊断：眩晕病 一 肝阳上亢证

西医诊断：高血压病

追问建议

检查建议

质控提示

保存问诊信息后，点击下方按钮生成追问建议

生成追问建议

陈桂芳 · 接诊中 病历 刚刚保存

图 6 保存后：中栏按模板生成结构化病历草稿并自动保存

7 智能辅助：追问建议

右栏 AI 根据当前病历自动生成**追问建议**，提示医生还应询问的关键问题。每条建议带优先级分类（**危险信号 / 高优先 / 建议问**）与预设答案选项：医生向患者追问后，**点选对应答案即自动写入病历「追问补充」章节**，无需手工记录。本例中 AI 针对头晕 + 高血压病史，提示了发作时血压、体位关系、肢体麻木言语不清（卒中筛查）、服药依从性等 6 个问题。另有「检查建议」「AI 生成诊断建议」入口，逻辑相同：AI 提示、医生决策采纳。

MediScribe

门诊部

初诊

复诊

取消接诊

陈桂芳 女 58岁 #BC6541

历史病历 影像分析 切换至急诊 张医生 外科

问诊信息

检验报告

问诊录入

填写后保存, AI自动同步建议

门诊

复诊

医生 您这个情况考虑是血压没控制好引起的头晕, 先做个头颅CT排除一下脑血管问题, 再查个血脂血糖。药不能再忘吃了。

语音原文会在后台保存; AI整理后展示预览, 确认无误后点击「插入病历」写入对应章节。

* 就诊时间 *

2026-07-14 14:10

* 病发时间 *

2026-07-11 08:00

* 主诉 *

头晕3天

现病史 *

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。

体格检查

生命体征快速录入

T 36.5 °C P 72 次/分 R 18 次/分

BP 162 / 96 mmHg SpO2 98 %

转住院

病历草稿已生成并自动保存。可继续录音补录, AI整理后点「插入病历」即可写入对应章节。

病历草稿

门诊病历

一键生成 润色 AI质控 出具最终病历 导出 Word

AI生成内容仅供参考, 请医生审核后使用

就诊时间: 2026-07-14 14:10 病发时间: 2026-07-11 08:00

【主诉】

头晕3天

【现病史】

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。

【既往史】

高血压病史7-8年

【过敏史】

[未填写, 需补充]

【个人史】

否认吸烟、饮酒史

【体格检查】

BP:162/96mmHg

望诊: [未填写, 需补充]

闻诊: [未填写, 需补充]

切诊·舌象: 舌红, 苔黄

切诊·脉象: 脉弦有力

其余阳性体征: [未填写, 需补充]

【辅助检查】

[未填写, 需补充]

【诊断】

中医诊断: 眩晕病 — 肝阳上亢证

西医诊断: 高血压病

追问建议

检查建议

质控提示

病历已生成。选择追问答案将追加至病历【追问补充】章节。

Q1 高优先 用药情况

近3天是否规律服用降压药?

规律服用, 未漏服 偶尔漏服1-2次

自行停药或减量 未服用降压药

有用 无用

Q2 危险信号 病情评估

近期血压监测值是多少?

收缩压140-159mmHg 收缩压160-179mmHg

收缩压≥180mmHg 未监测

有用 无用

Q3 建议问 伴随症状

有无其他伴随症状?

胸闷或心悸 视物模糊 肢体麻木或无力

头痛

有用 无用

Q4 建议问 诱因

有无可能诱发血压升高的因素?

情绪激动或紧张 高盐饮食 睡眠不足

近期感染或疼痛

有用 无用

Q5 既往史

既往高血压病史多久?

<1年 1-5年 5-10年 >10年

有用 无用

获取更多追问

图 7 追问建议：分级提示 + 点选答案直接写入病历

8 AI 质控：评分、缺陷分级、逐条修复

病历成稿后点击「AI 质控」，系统按病历书写规范对全文逐章节检查，输出：

- 质控总分与等级：**本例首次质控 88 分、**不合格**——存在结构性问题时系统**禁止出具病历**；

- **必须修复项**：影响病历合规的结构性缺陷，逐条列出扣分（本例 4 项：现病史缺诊治经过、缺望诊、缺闻诊、辅助检查未记录）；
- **质量建议项**：不影响出具但建议完善的内容（本例：过敏史、注意事项未填写）。

每条缺陷支持「**逐条修复**」：AI 依据病历上下文生成该处的修复文本，填入可编辑的建议框，医生审阅（可修改）后点「写入病历」才落入正文。写入的 AI 补全内容会以高亮标识，待医生确认。本例将 4 项必须修复逐条处理后点「重新质控」，得分 100 分、合格，放行签发。

MediScribe

门诊部

初诊

复诊

取消接诊

陈桂芳 女 58岁 #BC6541

历史病历 影像分析 切换至急诊 张医生 外科

问诊信息

检验报告

问诊录入

填写后保存, AI自动同步建议

门诊

复诊

——舌红, 苔黄。再把个脉——脉弦有力。

医生 您这个情况考虑是血压没控制好引起的头晕, 先做个头颅CT排除一下脑血管问题, 再查个血脂血糖。药不能再忘吃了。

语音原文会在后台保存; AI整理后展示预览, 确认无误后点击「插入病历」写入对应章节。

* 就诊时间 *

2026-07-14 14:10

* 病发时间 *

2026-07-11 08:00

* 主诉 *

头晕3天

现病史 *

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。

体格检查

生命体征快速录入

T 36.5 °C P 72 次/分 R 18 次/分

BP 162 / 96 mmHg SpO2 98 %

转住院

病历草稿已生成并自动保存。可继续录音补录, AI整理后点「插入病历」即可写入对应章节。

病历草稿

门诊病历

一键生成 润色 AI质控 补全缺失项 结构未通过(88分) 导出 Word

AI生成内容仅供参考, 请医生审核后使用

就诊时间: 2026-07-14 14:10 病发时间: 2026-07-11 08:00

【主诉】

头晕3天

【现病史】

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。

【既往史】

高血压病史7-8年

【过敏史】

[未填写, 需补充]

【个人史】

否认吸烟、饮酒史

【体格检查】

BP:162/96mmHg

望诊: [未填写, 需补充]

闻诊: [未填写, 需补充]

切诊·舌象: 舌红, 苔黄

切诊·脉象: 脉弦有力

其余阳性体征: [未填写, 需补充]

【辅助检查】

[未填写, 需补充]

【诊断】

中医诊断: 眩晕病 肝阳上亢证

西医诊断: 高血压病

追问建议 检查建议 质控提示

88分 不合格 (4项必须修复)

存在结构性问题, 需修复后才可出具

88分 (不合格), 结构问题4项需修复, 质量建议3条

必须修复 (共4项, 修复后重新质控即可出具病历)

现病史 (实际扣2/20分)

必须修复 中风险 现病史 -2分

缺诊治经过

修复建议 (可编辑) ...

逐条修复 写入病历

体格检查 (实际扣5/10分)

必须修复 中风险 望诊 -2.5分

缺望诊 (神色/形态)

修复建议 (可编辑) ...

逐条修复 写入病历

必须修复 中风险 闻诊 -2.5分

缺闻诊 (语声/气味)

修复建议 (可编辑) ...

图 8 AI 质控面板: 首次 88 分不合格, 必须修复 4 项 + 质量建议 3 项, 不合格禁止出具

MediScribe

门诊部

初诊

复诊

取消接诊

陈桂芳 女 58岁 #BC6541

历史病历 影像分析 切换至急诊 张医生 外科

问诊信息

检验报告

问诊录入

填写后保存, AI自动同步建议

门诊

复诊

舌红, 苔黄。再把个脉——脉弦有力。

医生 您这个情况考虑是血压没控制好引起的头晕, 先做个头颅CT排除一下脑血管问题, 再查个血脂血糖。药不能再忘吃了。

语音原文会在后台保存; AI整理后展示预览, 确认无误后点击「插入病历」写入对应章节。

就诊时间

2026-07-14 14:10

病发时间

2026-07-11 08:00

主诉

头晕3天

现病史

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。

体格检查

生命体征快速录入

T 36.5 °C P 72 次/分 R 18 次/分 BP 162 / 96 mmHg SpO2 98 %

病历草稿已生成并自动保存。可继续录音补录, AI整理后点「插入病历」即可写入对应章节。

转住院

病历草稿

门诊病历

一键生成 润色 重新质控 补全缺失项 结构未通过(88分) 导出 Word

AI生成内容仅供参考, 请医生审核后使用

本次 AI 补全 1 项 (点击 chip 查看, 点 × 放弃; 编辑该行后高亮消失): 望诊 ×

就诊时间: 2026-07-14 14:10 病发时间: 2026-07-11 08:00

【主诉】

头晕3天

【现病史】

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。

【既往史】

高血压病史7-8年

【过敏史】

[未填写, 需补充]

【个人史】

否认吸烟、饮酒史

【体格检查】

BP:162/96mmHg
望诊: 患者神志清楚, 精神可, 形态自如, 无强迫体位, 面色略红。
闻诊: [未填写, 需补充]
切诊·舌象: 舌红, 苔黄
切诊·脉象: 脉弦有力
其余阳性体征: [未填写, 需补充]

【辅助检查】

[未填写, 需补充]

【诊断】

中医诊断: 眩晕病 — 肝阳上亢证

追问建议 检查建议 质控提示

88分 不合格 (4项必须修复)

存在结构性问题, 需修复后才可出具
88分 (不合格), 结构问题4项需修复, 质量建议3条

必须修复 (共4项, 修复后重新质控即可出具病历)

现病史 (实际扣 2/20 分)

必须修复 中风险 现病史 -2分

缺诊治经过
修复建议 (可编辑) ...
逐条修复 写入病历

体格检查 (实际扣 5/10 分)

必须修复 中风险 望诊 -2.5分

缺望诊 (神色/形态)
患者神志清楚, 精神可, 形态自如, 无强迫体位, 面色略红。
逐条修复 已写入

必须修复 中风险 闻诊 -2.5分

缺闻诊 (语声/气味)
修复建议 (可编辑) ...

图 9 逐条修复: AI 生成「望诊」修复文本, 医生确认后写入病历并高亮提示

MediScribe

门诊部

初诊

复诊

取消接诊

陈桂芳 女 58岁 #BC6541

历史病历 影像分析 切换至急诊 张医生 外科

问诊信息

检验报告

问诊录入

填写后保存, AI自动同步建议

门诊

复诊

医生

您这个情况考虑是血压没控制好引起的头晕, 先做个头颅CT排除一下脑血管问题, 再查查血脂血糖。药不能再忘吃了。

语音原文会在后台保存; AI整理后展示预览, 确认无误后点击「插入病历」写入对应章节。

就诊时间

2026-07-14 14:10

病发时间

2026-07-11 08:00

主诉

头晕3天

现病史

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。

体格检查

生命体征快速录入

T 36.5 °C P 72 次/分 R 18 次/分

BP 162 / 96 mmHg SpO2 98 %

转住院

病历草稿已生成并自动保存。可继续录音补录, AI整理后点「插入病历」即可写入对应章节。

病历草稿

门诊病历

一键生成

润色

AI质控

补全缺失项

出具最终病历

导出 Word

AI生成内容仅供参考, 请医生审核后使用

本次AI补全4项 (点击chip查看, 点×放弃; 编辑该行后高亮消失):

望诊

现病史

闻诊

辅助检查

就诊时间: 2026-07-14 14:10 病发时间: 2026-07-11 08:00

【主诉】

头晕3天

【现病史】

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。发病以来, 患者未至医院就诊及检查, 自行间断服用苯磺酸氨氯地平 (近3天偶有漏服1-2次), 未予其他特殊治疗。

【既往史】

高血压病史7-8年

【过敏史】

[未填写, 需补充]

【个人史】

否认吸烟、饮酒史

【体格检查】

BP:162/96mmHg

望诊: 患者神志清楚, 精神可, 形态自如, 无强迫体位, 面色略红。

闻诊: 患者语音清晰, 气息平稳, 未闻及异常气味。

切诊·舌象: 舌红, 苔黄

切诊·脉象: 脉弦有力

其余阳性体征: [未填写, 需补充]

【辅助检查】

患者于2026年7月14日就诊, 发病以来未至医院行相关辅助检查。

【诊断】

中医诊断: 眩晕病 肝阳上亢证

西医诊断: 高血压病

追问建议

检查建议

质控提示

100分

合格病历

(达到合格标准)

结构检查通过, 可出具病历

质控通过 (100分合格), 质量建议4条

质量建议 (共4项, 不影响出具, 但建议改进)

质量建议

高风险

过敏史

过敏史未填写, 需补充。

修复建议 (可编辑) ...

逐条修复

写入病历

质量建议

中风险

体格检查

其余阳性体征未填写, 需补充。

修复建议 (可编辑) ...

逐条修复

写入病历

质量建议

中风险

治疗意见及措施

注意事项未填写, 需补充。

修复建议 (可编辑) ...

逐条修复

写入病历

质量建议

低风险

现病史

图 10 修复完成后重新质控: 100 分合格, 「病历质控通过, 可以签发」

9 医生审核, 出具最终病历

点击「出具最终病历」进入签发流程, 系统设置了**双重确认**:

- **AI 补全确认拦截：**若病历中还有 AI 补全但医生未确认的内容（本例 4 处：望诊、现病史、闻诊、辅助检查），系统先弹窗列出这些字段，医生必须逐项审核后选择「一并接受并签发」或返回修改——**任何 AI 产生的文字都不会未经医生确认进入最终病历；**
- **全文预览 + 签发确认：**弹出病历全文预览，医生勾选「我已认真阅读以上病历内容，确认内容真实、完整，同意签发」后，「确认签发」按钮才可点击。

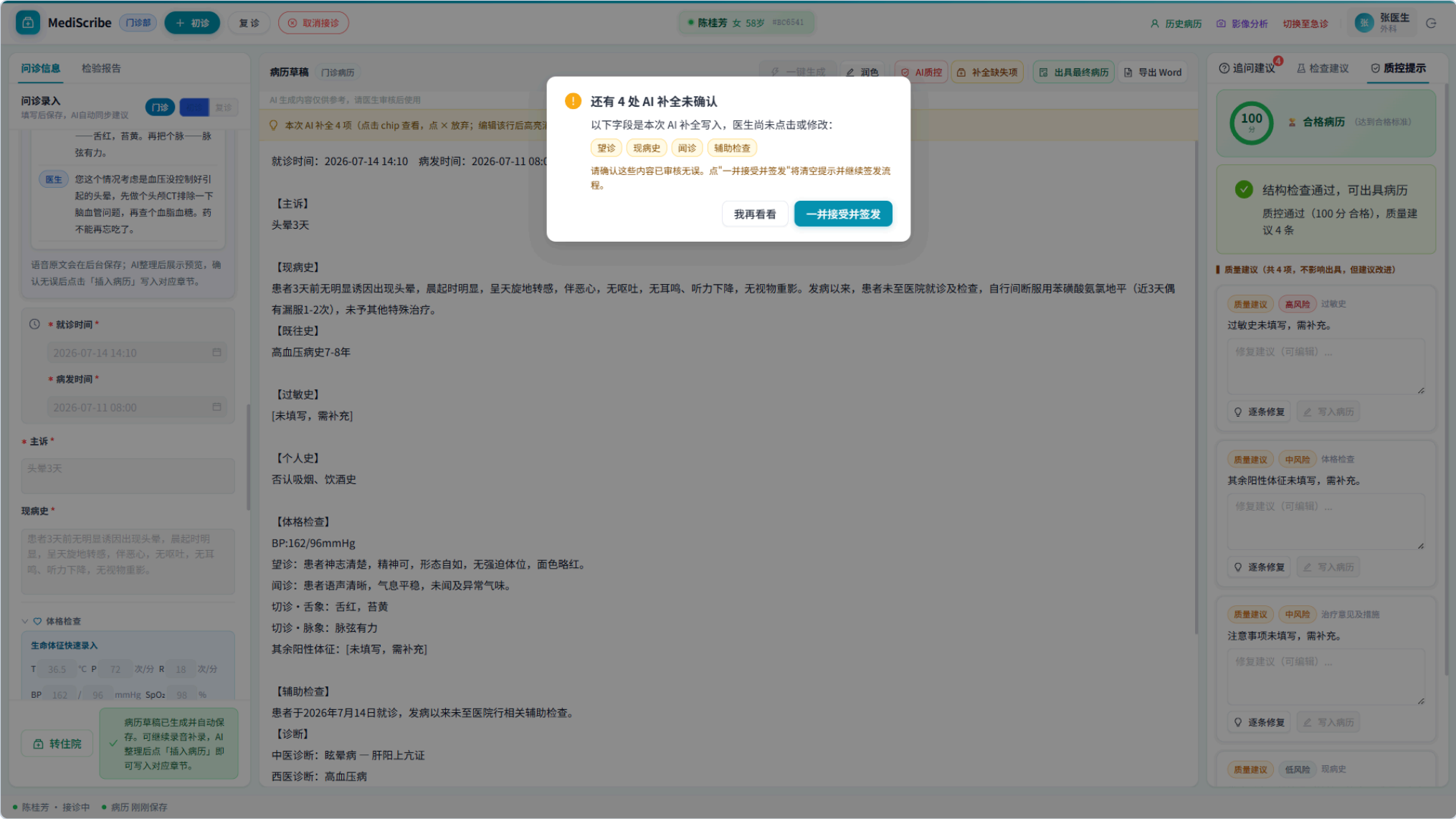


图 11 签发拦截：AI 补全内容未经医生确认时，先弹窗要求逐项审核



图 12 签发预览：全文核对 + 勾选确认后 方可签发

10 签发完成：锁定、打印、导出、归档 HIS 衔接点 ②

确认签发后，病历标记「已签发」并**锁定为只读，不可再修改**，界面显示签发时间戳，提供「打印」「导出 Word」功能。签发的病历进入患者档案，通过「历史病历」可按患者查询调阅：本例患者陈桂芳（病案号 211844）名下已有 1 份已签发门诊病历。

与 HIS 对接后：**医生确认签发这一时点，即触发病历回写**——我方将完整门诊病历（主诉、现病史、既往史、体格检查、中医四诊、诊断、诊疗意见等全套字段）连同就诊流水号调用 HIS 回写接口写入，并调用刷新接口使 HIS 病历页面即时显示，供医生在 HIS 内最终核对保存。回写以就诊流水号定位，同一次就诊重复回写为覆盖更新，不产生重复病历。

MediScribe

门诊部

+ 初诊

复诊

取消接诊

陈桂芳 女 58岁 #BC6541

历史病历 影像分析 切换至急诊 张医生 外科

问诊信息 检验报告

问诊录入

填写后保存，AI自动同步建议

门诊 复诊

医生 您这个情况考虑是血压没控制好引起的头晕，先做个头颅CT排除一下脑血管问题，再查个血脂血糖。药不能再忘吃了。

语音原文会在后台保存；AI整理后展示预览，确认无误后点击「插入病历」写入对应章节。

* 就诊时间 *

2026-07-14 14:10

* 病发时间 *

2026-07-11 08:00

* 主诉 *

头晕3天

现病史 *

患者3天前无明显诱因出现头晕，晨起时明显，呈天旋地转感，伴恶心，无呕吐，无耳鸣、听力下降，无视物重影。

√ 体格检查

生命体征快速录入

T 36.5 °C P 72 次/分 R 18 次/分

BP 162 / 96 mmHg SpO2 98 %

转住院

病历草稿已生成并自动保存。可继续录音补录，AI整理后点「插入病历」即可写入对应章节。

病历草稿 已签发 · 2026/7/14 14:24:17 门诊病历

一键生成 润色 AI质检 出具最终病历 导出 Word 打印

✓ 病历已签发，不可修改

就诊时间：2026-07-14 14:10 病发时间：2026-07-11 08:00

【主诉】
头晕3天

【现病史】
患者3天前无明显诱因出现头晕，晨起时明显，呈天旋地转感，伴恶心，无呕吐，无耳鸣、听力下降，无视物重影。发病以来，患者未至医院就诊及检查，自行间断服用苯磺酸氨氯地平（近3天偶有漏服1-2次），未予其他特殊治疗。

【既往史】
高血压病史7-8年

【过敏史】
[未填写，需补充]

【个人史】
否认吸烟、饮酒史

【体格检查】
BP:162/96mmHg
望诊：患者神志清楚，精神可，形态自如，无强迫体位，面色略红。
闻诊：患者语声清晰，气息平稳，未闻及异常气味。
切诊·舌象：舌红，苔黄
切诊·脉象：脉弦有力
其余阳性体征：[未填写，需补充]

【辅助检查】
患者于2026年7月14日就诊，发病以来未至医院行相关辅助检查。

【诊断】
中医诊断：眩晕病 一 肝阳上亢证
西医诊断：高血压病

追问建议 检查建议 质控提示

100分 合格病历 (达到合格标准)

✓ 结构检查通过，可出具病历
质控通过 (100分合格)，质量建议4条

质量建议 (共4项，不影响出具，但建议改进)

质量建议 高风险 过敏史
过敏史未填写，需补充。
修复建议 (可编辑) ...
逐条修复 写入病历

质量建议 中风险 体格检查
其余阳性体征未填写，需补充。
修复建议 (可编辑) ...
逐条修复 写入病历

质量建议 中风险 治疗意见及措施
注意事项未填写，需补充。
修复建议 (可编辑) ...
逐条修复 写入病历

质量建议 低风险 现病史

陈桂芳 · 接诊中 病历 3 分钟前保存

图 13 已签发状态：病历锁定不可修改，可打印 / 导出 Word（对接后此时点回写 HIS）

MediScribe

门诊部

+ 初诊

复诊

取消接诊

陈桂芳 女 58岁 #BC6541

问诊信息

检验报告

问诊录入

填写后保存, AI自动同步建议

门诊

复诊

——舌红, 苔黄。再把个脉——脉弦有力。

医生 您这个情况考虑是血压没控制好引起的头晕, 先做个头颅CT排除一下脑血管问题, 再查个血脂血糖。药不能再忘吃了。

语音原文会在后台保存; AI整理后展示预览, 确认无误后点击「插入病历」写入对应章节。

* 就诊时间 *

2026-07-14 14:10

* 病发时间 *

2026-07-11 08:00

* 主诉 *

头晕3天

现病史 *

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。

体格检查

生命体征快速录入

T 36.5 °C P 72 次/分 R 18 次/分

BP 162 / 96 mmHg SpO2 98 %

病历草稿已生成并自动保存。可继续录音补录, AI整理后点「插入病历」即可写入对应章节。

转住院

病历草稿

已签发 - 2026/7/14 14:24:17

门诊病历

一键生成

润色

AI质控

导出

✓ 病历已签发, 不可修改

就诊时间: 2026-07-14 14:10 病发时间: 2026-07-11 08:00

【主诉】

头晕3天

【现病史】

患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时明显, 呈天旋地转感, 伴恶心, 无呕吐, 无耳鸣、听力下降, 无视物重影。发病以来, 患者未至医院就诊及检查, 自行间断服用苯有漏服1-2次), 未予其他特殊治疗。

【既往史】

高血压病史7-8年

【过敏史】

[未填写, 需补充]

【个人史】

否认吸烟、饮酒史

【体格检查】

BP:162/96mmHg

望诊: 患者神志清楚, 精神可, 形态自如, 无强迫体位, 面色略红。

闻诊: 患者语音清晰, 气息平稳, 未闻及异常气味。

切诊·舌象: 舌红, 苔黄

切诊·脉象: 脉弦有力

其余阳性体征: [未填写, 需补充]

【辅助检查】

患者于2026年7月14日就诊, 发病以来未至医院行相关辅助检查。

【诊断】

中医诊断: 眩晕病 肝阳上亢证

西医诊断: 高血压病

患者档案查询

陈桂芳 女 58岁 #211844

共 1 份已签发病历

换患者

门诊·初诊 门诊病历

2026/7/14 14:24:17

就诊时间: 2026-07-14 14:10 病发时间: 2026-07-11 08:00

【主诉】 头晕3天 【现病史】 患者3天前无明显诱因出现头晕, 晨起时...

查看

图 14 患者档案: 已签发病历按患者归档, 随时调阅

三、与 HIS 系统的衔接汇总

整个流程中与 HIS 的数据交互只有「一进一出」两类消息，均以**就诊流水号 (visit_id)** 串联；病历内容完全在 MediScribe 工作台内产生，不需要 HIS 推送检验报告、医嘱或历史数据。消息字段、签名鉴权、幂等等细节以双方接口规范文档为准，与本文流程一一对应：

方向	时点	消息	内容	对应本文环节
HIS → 我方	医生在 HIS 点「接诊」	接诊推送	就诊流水号、患者姓名/性别/出生日期、科室、医生、机构代码（此刻尚无主诉，不需推送）	替代步骤 3「接诊建档」：患者自动派入医生工作台并叫号提醒
我方 → HIS	医生确认签发病历后	病历回写（写入 + 刷新两步）	完整门诊病历全套字段（结构化字段 + 全文）+ 就诊流水号；HIS 写入后台并刷新病历页面，以草稿待确认状态呈现；同一就诊重复回写为覆盖更新，不产生重复病历	紧接步骤 10「签发归档」：医生在 HIS 内核对保存后生效

关于传输通道：已双方确认采用 WebSocket 长连接（wss）——由 HIS 从院内主动向我方建立一条加密长连接，接诊消息沿此连接上行、病历回写沿同一连接下行；HIS 无需对外开放任何接口，我方也无需连入院内网、不在院内部署任何程序。消息字段、签名鉴权与幂等约定以双方接口规范（v1.4 单通道版）为准，与本文流程一一对应。

四、安全与质量保障要点

- **医生主导**：AI 全程只做「生成建议、等待确认」，追问答案点选写入、质控修复写入、最终签发，每一步都由医生操作确认；
- **AI 补全强制审核**：AI 补全的内容带高亮标识，签发前若有未确认项会被系统拦截（见图 11）；
- **数值不编造**：血压、体温等测量值只取医生口述的实测数据，缺失即留白，绝不由 AI 生成；
- **签发即锁定**：签发后病历只读、带时间戳，保证回写 HIS 的内容与医生确认的版本一致；
- **全程留痕**：原始录音、转写全文、AI 生成记录、质控记录均在后台留档，可溯源。